

CAPÍTULO 2.2

Dolor Torácico

PERFIL EUNACOM 1.01.2.004

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

El **dolor torácico** es un síntoma cardinal en medicina, con una amplia gama de causas, algunas de las cuales son potencialmente mortales. La clave es identificar rápidamente las condiciones graves para asegurar un manejo adecuado.

Causas del Dolor Torácico

Las causas del dolor torácico pueden ser muy variadas, abarcando sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, musculoesquelético y neurológico.

• Causas Graves/Potencialmente Mortales:

- - **Infarto agudo al miocardio (IAM) / Síndrome coronario agudo (SCA)**

- - **Tromboembolismo pulmonar (TEP)**

- - **Dissección aórtica**

- - **Neumotórax**

- - **Pericarditis aguda** (puede ser grave si causa taponamiento)

• Otras Causas (frecuentes pero generalmente menos graves):

- - Costocondritis

- - Miocarditis

- - Espasmo esofágico

- - **Neumonía**

- - **Herpes Zóster**

- - Reflujo gastroesofágico

- - Ansiedad/ataque de pánico

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Es fundamental no subestimar el dolor torácico. La no identificación y manejo temprano de causas graves como el infarto agudo al miocardio puede llevar a consecuencias fatales y responsabilidades médico-legales.

Aproximación Diagnóstica Inicial

La aproximación al dolor torácico depende de la especificidad de la clínica.

- **Clínica Específica:** Si el paciente presenta una clínica clara que apunta a una causa específica (ej. dolor tipo puntada, tos, fiebre, expectoración mucopurulenta sugerente de **Neumonía**), el manejo se orienta a esa patología.
- **Clínica Inespecífica:** Si el dolor es vago y no sugiere una causa obvia, se deben realizar al menos un **Electrocardiograma (ECG)** y una **Radiografía de tórax**.

Sospecha de Síndrome Coronario Agudo (SCA)

Si existe la posibilidad de un **Síndrome coronario agudo** (ej. paciente de 50 años, diabético, hipertenso), el estudio debe ser más exhaustivo.

• Exámenes Obligatorios:

- - **Electrocardiograma**

- - **Enzimas cardíacas (troponinas)**

- **Manejo Inmediato:** Si no se dispone de un ECG en el lugar de atención, el paciente debe ser **derivado de urgencia** a un centro de mayor complejidad.

- **Síndrome Coronario Agudo Probable:** Si el dolor tiene características típicas de un SCA, el paciente debe manejarse como tal, incluso antes de tener los resultados del ECG o las troponinas.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

¡No se les pase un infarto! Es una de las principales razones de juicios por negligencia médica. El médico general debe ser capaz de identificarlo y derivarlo urgentemente.

Cuadros Clínicos Específicos del Dolor Torácico Agudo

1. Síndrome Coronario Agudo (SCA)

La clínica clásica del SCA es crucial de conocer.

- **Antecedentes:** Factores de riesgo cardiovascular (diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, edad avanzada, antecedentes familiares).

• Dolor:

- - Inicio: Súbito, intenso (EVA ≥ 7 , aunque no siempre).
- - Carácter: Opresivo ("aprieta el pecho") o sordo ("no lo puedo describir bien").
- - Localización: Precordial o retroesternal.
- - Irradiación: Hacia brazos (clásico: izquierdo, pero puede ser derecho), hombros, cuello o mandíbula.

• Síntomas Acompañantes:

- - Sensación de muerte inminente.

- - **Disnea.**

- - Sudoración.

- - Síntomas neurovegetativos (ej. náuseas).

• Examen Físico:

- - A veces: R4 (disfunción diastólica), R3 (disfunción sistólica).

- - **Taquicardia.**

- - **Hipertensión arterial o Hipotensión arterial.**

2. Dissección Aórtica

Puede ser similar al SCA, pero con diferencias clave.

• Antecedentes:

- - Frecuente: **Hipertensión arterial** crónica (dissección espontánea).
- - Trauma de tórax (dissección traumática).

• Dolor:

- - Inicio: Súbito, muy intenso.
- - Carácter: Lancinante ("como una lanza"), transfixiante (del pecho a la espalda).
- - Irradiación: Al dorso.
- - Sensación de muerte inminente.

• Signos Específicos:

- - **Soplo diastólico de insuficiencia aórtica:** El flap de dissección afecta la raíz aórtica.
- - **Asimetría de pulsos:** Radial o entre pulsos superiores e inferiores (el flap ocluye arterias).
- - **Crisis hipertensiva:** Presiones muy elevadas (ej. 230/120 mmHg).
- - **Disfonía:** Por compresión del nervio laríngeo recurrente por el cayado aórtico disecado.

3. Tromboembolismo Pulmonar (TEP)

Sospechar en pacientes con factores de riesgo.

• Inicio: Súbito.

- **Síntomas:** **Disnea, Taquicardia** (signo más frecuente, inespecífico).

- **Dolor:** Tipo pleurítico (aumenta con la inspiración).

- **Otros:** Hemoptisis.

• Factores de Riesgo para Trombosis venosa profunda (TVP):

- - Postoperados.
- - Mujeres embarazadas o puérperas.
- - **Cáncer.**
- - Trombofilias.

• Electrocardiograma (ECG):

- - Patrón clásico (infrecuente): S1Q3T3 (onda S en D1, onda Q y T invertida en D3).
- - Más frecuente: Simplemente **Taquicardia sinusal**.

4. Neumotórax

También de inicio súbito, con hallazgos específicos al examen físico.

- **Inicio:** Súbito.
- **Síntomas:** **Disnea**, dolor que aumenta con la inspiración (pleurítico).
- **Examen Físico:**
 - - **Hipersonoridad** a la percusión.
 - - **Disminución del murmullo pulmonar** a la auscultación.
- **Pacientes Típicos:** Jóvenes, delgados, longilíneos (asociado a rotura de bullas apicales).

5. Pericarditis Aguda

Dolor con características posicionales.

- **Inicio:** No necesariamente agudo, puede ser subagudo (horas o días).
- **Dolor:**
 - - Aumenta con la inspiración.

6. Costocondritis

Causa frecuente de dolor torácico musculoesquelético.

- **Dolor:**
 - - A la presión o compresión de la unión costocondral.
 - - Aumenta con la inspiración.
 - - **"One finger pain":** Dolor exquisito y localizado al presionar el punto inflamado.
- **Pacientes Típicos:** Frecuente en pacientes jóvenes.
- **Causa:** Generalmente idiopática, se cree que es una reacción inmunológica.

7. Espasmo Esofágico

Dolor torácico de origen gastrointestinal.

- **Asociación:** Frecuentemente con **Reflujo gastroesofágico**.
- **Momento:** Postprandial.
- **Respuesta al Tratamiento:** Disminuye significativamente con **nitritos** (ej. nitroglicerina).

NOTA CLÍNICA

El espasmo esofágico puede simular un SCA debido a la inervación compartida y la naturaleza opresiva del dolor. La respuesta a los nitritos es un hallazgo clave, ya que relajan el músculo liso esofágico, al igual que los vasos coronarios, lo que puede confundir el diagnóstico diferencial.

- - Disminuye al inclinarse hacia adelante o en posición genupectoral.
- - Aumenta al acostarse en decúbito supino.
- **Electrocardiograma (ECG):**
 - - **Supradesnivel del segmento ST** difuso, cóncavo hacia arriba o en "jota".
- **Pacientes Típicos:** Generalmente pacientes jóvenes (en contraste con el IAM).

NOTA CLÍNICA

El supradesnivel del ST en la pericarditis se debe a la inflamación del epicardio que afecta la repolarización ventricular temprana, manifestándose como una elevación difusa y cóncava del ST, a diferencia del supradesnivel isquémico que suele ser más localizado y convexo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante un dolor torácico sospechoso de SCA, siempre priorice el descarte de la causa coronaria, incluso si el dolor mejora con nitritos, ya que estos también pueden aliviar el dolor de un espasmo esofágico. Es mejor sobretratar un espasmo esofágico como SCA que subtratar un infarto.

La evaluación cuidadosa de la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios iniciales son fundamentales para diferenciar estas condiciones y asegurar el manejo adecuado.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

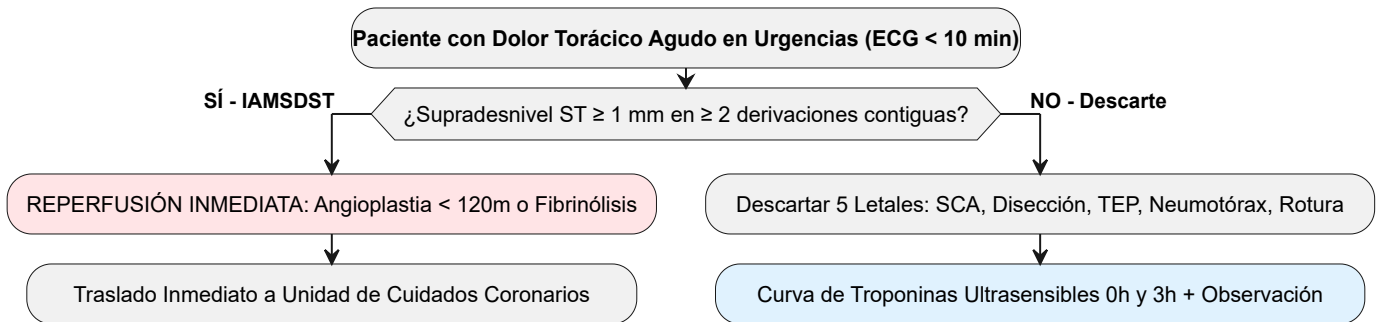
"Hombre de 58 años en urgencias por dolor torácico intenso de 45 min. ECG < 10 min."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Descartar 5 letales: SCA, Disección Aórtica, TEP, Neumotórax a Tensión y Rotura Esofágica.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El ECG debe realizarse en los primeros 10 minutos de un paciente con dolor torácico
- Las 5 causas letales son: SCA, disección aórtica, TEP, neumotórax a tensión y taponamiento cardíaco
- La causa más frecuente de dolor torácico en urgencias es musculoesquelética
- El dolor típico cumple 3 criterios: opresivo retroesternal, con esfuerzo, cede con reposo
- La disección aórtica se presenta con dolor desgarrante y asimetría de pulsos
- El HEART score estratifica el riesgo de eventos cardíacos a 6 semanas
- El espasmo esofágico puede simular angina y responder a nitroglicerina

FIGURA 2.2B: ALGORITMO DE DESCARTE DE LAS 5 CAUSAS LETALES DE DOLOR TORÁCICO

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DOLOR TORÁCICO)**PREGUNTA 1**

Hombre de 55 años consulta en urgencias por dolor torácico opresivo de 2 horas. ¿Cuál es la primera acción a realizar?

- A)** Radiografía de tórax
- B)** ECG de 12 derivaciones
- C)** Troponinas
- D)** AngioTC de tórax
- E)** Ecocardiograma

PREGUNTA 2

Paciente de 70 años con dolor torácico desgarrante de inicio súbito que se irradia a la espalda. PA en brazo derecho 180/100, en brazo izquierdo 130/70. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Infarto agudo de miocardio
- B)** Disección aórtica
- C)** Tromboembolismo pulmonar
- D)** Pericarditis aguda
- E)** Espasmo esofágico

PREGUNTA 3

Mujer de 25 años consulta por dolor torácico agudo con disnea, taquicardia y palpitaciones. Refiere parestesias en manos. ECG normal. ¿Cuál es la causa más probable?

- A)** Síndrome coronario agudo
- B)** Tromboembolismo pulmonar
- C)** Pericarditis aguda
- D)** Crisis de pánico
- E)** Neumotórax espontáneo

RESUMEN: DOLOR TORÁCICO

El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuentes en urgencias. La prioridad es identificar las causas potencialmente letales: síndrome coronario agudo, disección aórtica, tromboembolismo pulmonar, neumotórax a tensión y taponamiento cardíaco. La evaluación inicial incluye anamnesis dirigida, examen físico, ECG de 12 derivaciones y troponinas. La clasificación del dolor torácico distingue entre dolor típico (opresivo, retroesternal, desencadenado por esfuerzo, que cede con reposo o nitroglicerina), dolor atípico (cumple 2 de 3 criterios) y dolor no cardíaco (cumple 0-1 criterios). La probabilidad pretest de enfermedad coronaria depende del tipo de dolor, edad, sexo y factores de riesgo cardiovascular. Las causas no cardíacas incluyen causas musculoesqueléticas (la más frecuente en urgencias), gastrointestinales (reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico), pleuropulmonares y psiquiátricas (crisis de pánico). La evaluación sistematizada con scores de riesgo como HEART score permite estratificar adecuadamente a los pacientes y definir la conducta entre alta precoz, observación o manejo invasivo.